



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : وفاء محمد عبدالمعطي احمد

العنوان : 9ش سرحان م الجامعه

الحى / المدينة : عين شمس

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 30-09-2026

رقم البطاقة : 27907110102205 رقم التليفون : 01118457278

العمر(تاريخ الميلاد) : 11-07-1979 المهنة : حاصل علي دبلوم

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: وفاء محمد عبدالمعطي احمد National ID: 27907110102205	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



وفاء
محمد عبد المعطي احمد
١ شن سرحان -م- الجامعة
المطرية - القاهرة

١٩٧٩/٠٧/٢١ ٢٧٩,٧١١,٠١,٢٢,٥

JP8314279



٢٠٢٢/١١ ٢٧٩٠٧٩١٠١٠٢٢٠٥
حاصله على دبلوم تجاره



انثى مملعة متزوجة
عبد الوهاب عبدالعزیز احمد
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/١٠/٣١ ١





Pathology Report

Name: وفاء محمد عبد المعطى

Age: 40 years.

Clinical data: Right breast mass

Specimen type: Lumpectomy with axillary clearance

Date: 15/9/2019

Lab. Number: 846

Hospital Number: 2947/2019

Gross Description:

Two specimens were received:

- A piece of breast tissue; 6x5x4 cm, showing an ill-defined firm greyish white mass; 3.5x2.2 cm, located (1.2, 2, 1.5, 1.5, 1&1) cm from (medial, lateral, upper, lower, superficial & deep) margins respectively
- Axillary specimen; 9x8 cm, entangling 17 nodules up to 2cm in diameter.

Microscopic Examination:

Microscopic examination revealed breast tissue showing infiltrating tumor formed of malignant ductal cells with moderate pleomorphism and moderate tubular differentiation. Other foci show infiltrating tumor formed of monotonous discohesive cells with hyperchromasia arranged in indian filing. No lymphovascular emboli. No perinural invasion. DCIS 5%, solid variant. Foci showing in situ lobular carcinoma. Surrounding breast shows fibrocystic changes. Free margins, upper margin showed florid adenosis. Lymph nodes 0/17 showing reactive sinus histiocytosis.



Ministry of Health
Central Health Laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m6178

Female	النوع	وفاء محمد عبدالمعطي	اسم المريض
القاهرة	العنوان	40 Y	السن
24/10/2019 10:43	تاريخ استلام العينة		تاريخ اخذ العينة
18/11/2019 13:27	تاريخ التقرير	مركز اورام دار السلام	طالب التحليل
		مركز اورام دار السلام	غاية

Primary Sample

Paraffin Block

Tset

ER, PR (according to Harvey scoring system)

Comment

Technique

Sample Received Was Treated by: - CONFIRM Anti-Estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal Primary antibody.- CONFIRM Anti-Progestosterone Receptor (PR) (1E2) Rabbit Monoclonal Primary Antibody.

Result:

ER: moderate nuclear staining of 80 % of tumour cells

PR: moderate nuclear staining of 10 % of tumour cells

Referral Lab

Comment

Conclusion:

ER POSITIVE (SCORE 7/8)

PR POSITIVE (SCORE 4/8)

Pathologist

د. إيمان رمزي

Lab Director

د. نورا ماهر

19 El-shekh Rohan Street, Abodeen, Cairo
Tel: (165) 7848544 - 7850398 Fax: (202) 7848544
Mobile: 01144267292

website: nlp (www.nlp-labs.net)

e-mail: pathologych@yahoo.com

قسم الباثولوجي، الإدارة المركزية للمختبرات

* This Test is Not Accredited By EGAC Not Recognized by ILA

تتم الاستفادة بالنتائج لمدة 30 يوم من تاريخ استلامها

Patient name: وفاء محمد عبد العاطي

Date: 18/8/2021

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had right CBS, 1year ago.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Heterogenous dense fibro glandular density (ACR C)
- Bilateral scattered typically benign macro calcifications.
- Right breast LOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and mild diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound also showed right breast LOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with no evidence of recurrent mass lesions.
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex,
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Bilateral typically benign calcifications.
- (BIRADS 2)

Best regards,
Dr\ Nehal hamdey, FEBR, MSC.



CANCER INSTITUTE

ONCOLOGY CENTER

NUCLEAR MEDICINE UNIT

معهد الأورام

مركز الأورام

وحدة الطب النووي

Patient Name: Wafaa Mohamed Abdelmouty,

Date: 24/12/2019

Tc-99m MDP bone scan

Technique

Delayed Whole body bone scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP

Report:

- Spondylo-degenerative changes are noticed in scoliotic dorsal & lumbar vertebrae
- No hot spot that account for definite osseous deposits could be detected over the imaged skeleton.
- Soft tissue changes are normally seen.

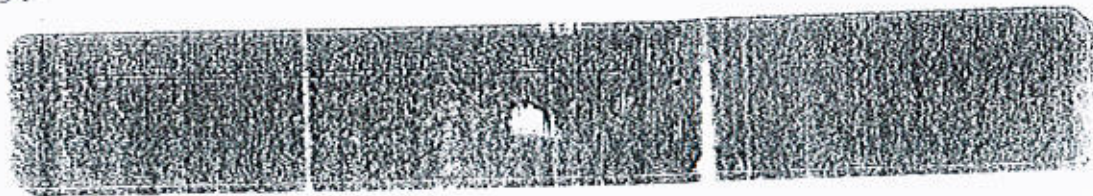
Opinion: -

- No definite evidence of osseous deposits.

Thanks for reference

Nuclear medicine Unit

Magdy koth , M.D



**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

Known case of breast mass.

1. Chest:

- Right breast mass is seen measuring about 2.6 x 2.1 cm.
- No pathologically enlarged axillary lymph nodes.
- Few bilateral tiny 2-3 mm micro-nodules are seen (for follow up).
- No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall.
- Normal appearance of the dorsal vertebrae.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size with diffuse low CT attenuation denoting fatty infiltration. No focal lesions or biliary radicle dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, pararenal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenal glands.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Right ovarian cyst is seen measuring about 1.7 cm in diameter.
- IUCD is seen.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic collections.

OPINION:

- *Right breast mass.*
- *Fatty hepatomegaly.*

Dr. Ahmed Rozeka, MSc

Dr. Amr Farouk, MD

٠١٠٠٦٤١٧٦٩
Sipi

١١٤٢٦٥٩٣٨٤



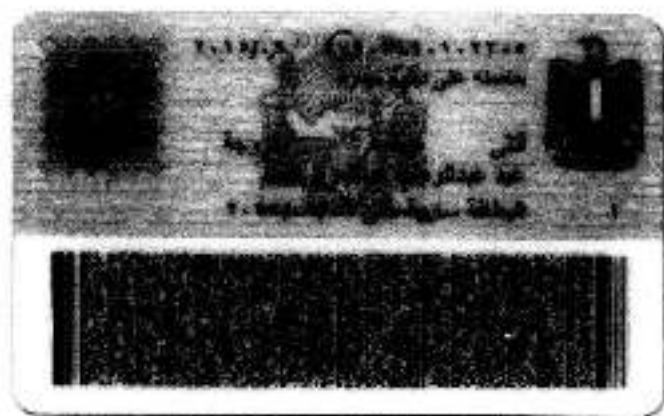
ERM036746430

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحصيل الشخصية

وفاء
محمد عبدالمطير احمد
اشرف مرغانيم . اللجنة
المطرية - القاهرة

٢٧٩.٧١١.١.٢٢.٥

GF0827925





To whom it may concern

Mrs Wafa Mohamed Abel moaty 40 years old female patient
presented with a diagnosis of right breast cancer after RT. WLE + Axillary
clearance

PATH: Infiltrating duct carcinoma G2, mass 3.5x2.2cm, LN -ve
0/17(T2N0) .

She was referred to us for PORT.

She received adjuvant post operative comprehensive radiotherapy.

Dose : 4500cGy/20f/4w 225 cGy/fx. + concomitant boost 1000cGy
/ 5 fx.

Started : 10-3-2020

Ended : 8-4-2020. With good tolerance .

Head of department
Dr. Hany William

8 - 4 - 2020



Name Wafaa Mohamed Abdelmoaty

Date: 7/8/2019

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

Known case of breast mass.

1. Chest:

- Right breast mass is seen measuring about 2.6 x 2.1 cm.
- No pathologically enlarged axillary lymph nodes.
- Few bilateral tiny 2-3 mm micro-nodules are seen (for follow up).
- No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall.
- Normal appearance of the dorsal vertebrae.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size with diffuse low CT attenuation denoting fatty infiltration. No focal lesions or biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenal glands.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Right ovarian cyst is seen measuring about 1.7 cm in diameter.
- UCD is seen.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic collections.

OPINION:

- ***Right breast mass.***
- ***Fatty hepatomegaly.***

Dr. Ahmed Rozeka, MSc

Dr. Amr Farouk, MD

Patient Name: Wafaa Mohamed Abdelmoaty.

Date: 24/12/2019

Tc-99m MDP bone scan

Technique :

Delayed Whole body bone scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP:

Report:

- Spondylo-degenerative changes are noticed in scoliotic dorsal & lumbar vertebrae.
- No hot spot that account for definite osseous deposits could be detected over the surveyed skeleton.
- Both kidneys are normally seen.

Opinion: -

- *No definite evidence of osseous deposits.*

Thanks for reference

Nuclear medicine Unit

Magdy kotb , M.D.



Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m6178

Female	: النوع	وفاء محمد عبدالمعطي	: اسم المريض
القاهرة	: العنوان	40 Y	: السن
24/10/2019 10:43	: تاريخ استلام العينة		: تاريخ اخذ العينة
18/11/2019 13.27	: تاريخ التقرير	مركز اورام دار السلام	: طالب التحليل
		مركز اورام دار السلام	: عناية

Primary Sample :

Paraffin Block

Tset :

ER & PR (according to Harvey scoring system)

Comment :

Technique:

Sample Recieved Was Treated by: - CONFIRM Anti-Estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal Primary antibody.- CONFIRM Anti-Progesterone Receptor (PR) (IE2) Rabbit Monoclonal Primary Ant.body.

Result:

ER: moderate nuclear staining of 80 % of tumour cells

PR: moderate nuclear staining of 10 % of tumour cells

Refrral Lab:

Comment:

Conclulsion:

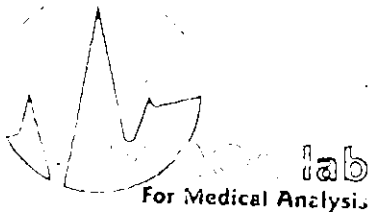
ER: POSITIVE (SCORE 7 / 8)

PR: POSITIVE (SCORE 4 / 8)

Pathologist:

د/أيناس رمزي

Lab Director: د/ تريزا ماهر



Lab code 507083 Req. Date 08/10/2022
Name وفاء محمد عبد المعطى مدام Sex Female Age 43 Years
Referred by حنان عزت اد Reporting Date 08/10/2022

Kidney Function Tests

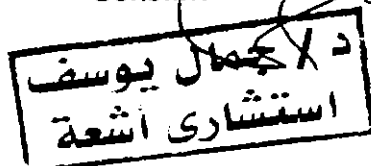
			<u>Reference Range</u>
Serum creatinine	0.85	mg/dl	0.5 - 1.5
Serum calcium (Total)	9.6	mg/dl	8.5 - 10.5
Serum calcium (Ionized)	1.2	mg/dl	1.10 - 1.31

- Normal Right side structure, tricuspid valve & junction (no mitral regurgitation or pulmonary hypertension), with PASP= 23 mmHg.
- Normal left atrium.
- No regional wall motions abnormalities at rest.
- No masses or thrombi by TTE.
- Normal pericardium.
- Intact septum

Conclusion:

- Normal echo study.

DR/ GAMAL YOUSSEF
Consultant Radiologist





وزارة الصحة والسكان
أمانة المركز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
حرم، سابقاً

Radiology Request

طلب الشعاع

Patient name: مها محمد

Hospital NO: 01919982

Age: Sex: Date: 1/1

Time:

Diagnosis:

Exam required:

Mammography

Clinical data (Reason of study):

A case of breast cancer

Surgeries:

for 1st follow up

Previous studies' result with dates:

US:

CT:

MRI:

Plain X-Ray:

القيمة		سعر الوحدة		الكمية المنصرفة	الكمية المطلوبة	الصف	مستلم
جنيه	قرش	جنيه	قرش				
							1
							2
							3
							4
							5
							6
الإجمالي							
الحسابات				قسم الأشعة		الطبيب المعالج	
الإسم:				الإسم:		الإسم:	
التوقيع:				التوقيع:		التوقيع:	

خطابات أورام

Patient Name : وفاء محمد عبدالمعطي

sex : female

Age: 40

Hosp.Word : CT

Patient status : outpatient

Path.No. : 846

IHC . No : 11863

Referring Doctor: السلام- هرمل

Date : 02-10-2019

Provisional Diagnosis: Request for Ki67 and E-cadherin.

Immunohistochemistry Report

CLINICAL/ RADIOLOGIC DATA

Lumpectomy with axillary clearance.

GROSS PATHOLOGY

Received 1 paraffin block.

IMMUNOHISTOCHEMISTRY

Immunostaining effectuated on 5 µm thick paraffin sections, the heat induced epitope retrieval using microwave, the ChemMate DAKO Envision, DAKO autostainer and the following antibodies:

- E- cadherin : positive on the neoplastic cells
- Ki67 : less than 20% of the neoplastic cells are positive.

CONCLUSION

Breast mass, lumpectomy, site unspecified : invasive duct carcinoma ONST, low proliferation fraction

Enclosed :

Slides :

Blocs :

مدير معمل الصبغات الهستومناعية

أ. د / هويدا عبدالعال

Director Immunohistochemical Lab

Prof. Howayda Abd El All

07-10-2019



Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m5519

Female	: النوع	وفاء محمد عبدالمعطي	: اسم المريض
القاهرة	: العنوان	40 Y	: السن
26/09/2019 13:08	: تاريخ استلام العينة		: تاريخ اخذ العينة
15/10/2019 09:14	: تاريخ التقرير	مركز اورام دار السلام	: طالب التحليل
		مركز اورام دار السلام	: عناية

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

HER2 neu (according to CAP scoring system)

Comment :

Technique :

Sample recieved was treated by : -VENTANA anti-HER2/neu (4E5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.

Result :

HER2/neu protein over expression : strong continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells.

Referral Lab :

Comment :

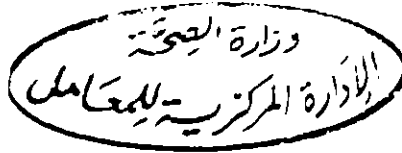
Conclusion :

HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : POSITIVE (SCORE 3+)

Pathologist:

د/اينس رمزي

Lab Director: د/ تريزا ماهر



A +ve فصيلة الدم



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
«هرمل سابقاً»

Doctor's Orders أوامر الطبيب

التشخيص:
اسم المريض: وفاء ك
نوع التغذية:
رقم الملف:

Chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canola site infection:

عجز وديس دم كليا نه
دهن مريض

هناك حالة
تغير كليا ١٠٠
توقيع الطبيب:

التاريخ:
الوقت:

Chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canola site infection:

تم حجز كيس دم من نفس الفصيلة
نرمس ألد
٩٩/٩/٩٠

AT
٩٩/٩/٩٠
(2847436) ٩٩/٩/٩٠
٩/٩/٩٠

التاريخ:
الوقت:

توقيع الطبيب:



Patient name: وفاء محمد عبد العاطي

Date: 18/8/2021

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had right CBS, 1year ago.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Heterogenous dense fibro glandular density (ACR C)
- Bilateral scattered typically benign macro calcifications.
- Right breast LOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and mild diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound also showed right breast LOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with no evidence of recurrent mass lesions.
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex,
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Bilateral typically benign calcifications.
- (BIRADS 2)

Best regards,
Dr\ Nehal hamdey, FEBR, MSC.



Diagnosis:

Right breast mass, Lumpectomy with axillary clearance,

- **Mixed ductal and lobular carcinoma I**
- **In situ lobular and solid DCIS (5%).**
- **No lymphovascular emboli.**
- **No perinural invasion.**
- **Free margins**
- **LN 0/17**
- **Stage T2 N0.**
- **The case for IHC; (ER, PR, Her2, Ki67 and E-Cadherin)**

Prof. Dr. Lubna-Omar

Dr. Marwa Mahmoud

Prof. Dr. Essam Ayad



Pathology Report

Name: وفاء محمد عبد المعطى

Age: 40 years.

Clinical data: Right breast mass

Specimen type: Lumpectomy with axillary clearance

Date: 15/9/2019

Lab. Number: 846

Hospital Number: 2947/2019

Gross Description:

Two specimens were received:

- A piece of breast tissue; 6x5x4 cm, showing an ill-defined firm greyish white mass; 3.5x2.2 cm, located (1.2, 2, 1.5, 1.5, 1&1) cm from (medial, lateral, upper; lower, superficial & deep) margins respectively.
- Axillary specimen; 9x8 cm, entangling 17 nodules up to 2cm in diameter.

Microscopic Examination:

Microscopic examination revealed breast tissue showing infiltrating tumor formed of malignant ductal cells with moderate pleomorphism and moderate tubular differentiation. Other foci show infiltrating tumor formed of monotonous discohesive cells with hyperchromasia arranged in indian filing. No lymphovascular emboli. No perinural invasion.

DCIS 5%, solid variant. Foci showing in situ lobular carcinoma.

Surrounding breast shows fibrocystic changes.

Free margins, upper margin showed florid adenosis.

Lymph nodes 0/17 showing reactive sinus histiocytosis.



Investigations

Patient name:

MR. no:

As directed by prof. Dr. Hassan El-Zohry
→ Herceptin
→ Tamoxifen 20mg monthly

17/11/2019
Dr. El-Zohry

Checked & Reviewed by Dr.

Date: Time:



التاريخ المرضي PERSONAL HISTORY

Patient name: Mr.no:

Age: Sex: ☐ Male ☐ Female

Occupation:

Marital History: ☐ M ☐ S ☐ W ☐ D

Children: ☐ Yes ☐ No number

Special Habits: ☐ Smoking ☐ Coffee ☐ Alcohol

Allergy: ☐ Yes ☐ No Comment:

Adverse drug reaction: ☐ Yes ☐ No Comment:

Complaints:

Present History:

40 yrs old ♀ patient, postmenopausal 3 m ago after ch
underwent lumpectomy + AC 15/9/2014
PT - maxillary ductal & lobular carcinoma
- DCIS 5% I
- no lymphovascular emboli
- no perineural invasion
- free margin
- LN 0/17
- T2N0

Past History (hospital admission & surgery):

14/12/2017 - ER 7/8
Bone scan - PR 4/8
free - HER2 (+3)
- Ki67 20%
• surgical:
• Diabetes mellitus:
• Blood Transfusion:

Family History:

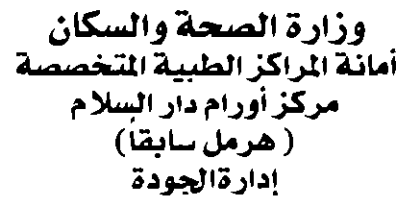
The patient received: 3x FEC => 3x Taxoter
adj ended on 10/2/2020
then patient was planned to start RTh

Psychosocial History: CAPCT 16/2/2020

Checked & Reviewed by Dr.

Date: Time:

low lying bilateral
millimetric insignificant
Palm nodules
→ no other mets





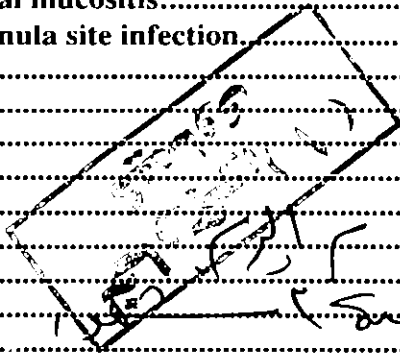
وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :
C. 19. / 09. 2019

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....



رئيس مركز أورام دار السلام
الوقت:

توقيع الطبيب :

د. خالد
م. خالد
د. خالد

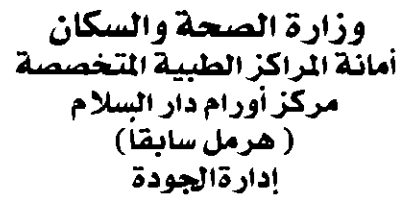
الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

د. خالد
م. خالد
د. خالد

توقيع الطبيب :

التاريخ : / /
الوقت :

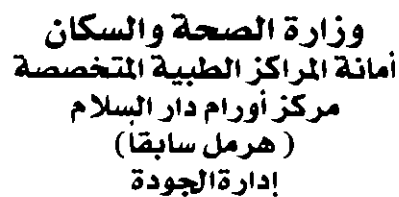


اسم المريض : د. فاطمة محمد
الرقم الطبي : ١٩ / ٤٧ / ٢٠٩

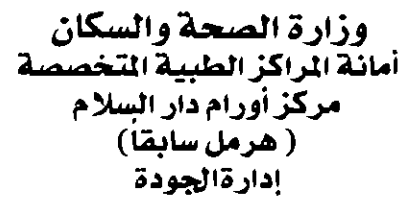
[illegible]

best

اردین ہائی
۱۱/۷
۲۰۰۷ء



الحرف Zoladex
+ ١٠ حقن (١٠ حقن)
للعلاج
٢٠٠٩/١٠/١٨



اسم المريض : د. محمد عبد الحميد
الرقم الطبي : ٩٩٤٧ / ١٩

can 11/2



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Dr. [Signature]

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

Zoladex 10, 8 mg

Arimidex 50

Oestradiol 0.5

clonidine

توقيع الطبيب :

التاريخ :
الوقت :

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

1/4/2023

→ Ca H

Prolia Postponed

→ for Arimidex / Zoladex

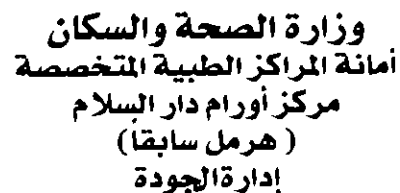
توقيع الطبيب :

التاريخ :
الوقت :

صيدلية خارجي

تم صرف ٢ حبة
٤/١
لم يصرح للقرار

تم صرف العلاج
٥/١
دايف



~ ~ ~ ~ ~



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

R/ Aramidex

R/ Zoladex 10.8 1x1 1x1x90 day

التاريخ: 26 / 11 / 2017
الوقت:

توقيع الطبيب :

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

20.11.2017

9.11.2017

9.11.2017

patient xfer to start chemo

for 2 weeks

التاريخ:
الوقت:

توقيع الطبيب :

9.11.2017

9.11.2017



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:..... 16/6/2021

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:.....

أراميدكس 1X1X60

زولادكس 3.6mg 120d

أوستيرون 1X1X60

دانه ألفا 1X1X60

16/6/2021

أ. الوكيل

م. م. م.

توقيع الطبيب :

التاريخ: / /

الوقت:

الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:.....

Mammogram & US in Sep 2021

Arimidex 1X1X60

Zoladex 3.6mg 120d

Osteon 1X1X60

Danalpha 1X1X60

14/7/2021

توقيع الطبيب :

التاريخ: / /

الوقت:



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:.....

4. د حنان عزت

Temp:.....

Oral mucositis:..... vaginal bleeding

Canula site infection:.....

D & C - endometrial hyperplasia

7-X-1-X-1 أراميدكس

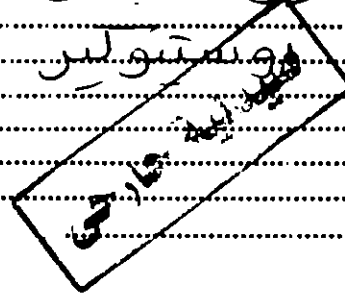
7-X-1-X-1 دولايدكس 2.7 كـ الجـ

7-X-1-X-1 دولايدكس 2.7 كـ الجـ

توقيع الطبيب :

0-1-19

/ / التاريخ:
الوقت:



الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:.....

- She is regular on hormonal tht;

- No CLO.

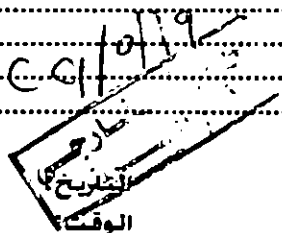
- Due for next mammography next Sept. 2021

2-X-1-X-1 أراميدكس

2-X-1-X-1 دولايدكس 2.7 كـ الجـ

2-X-1-X-1 دولايدكس 2.7 كـ الجـ

/ / التاريخ:
الوقت:



دار الأورام
0-1-19



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي : E.R..P.R..her.2...+ve

الأوامر

chest:..... ٩. x ١ x ١ ٥ تامويفين
Temp:..... ٦. x ١ x ١ بوتير
Oral mucositis:..... ٦. x ١ x ١ وان المنا
Canula site infection..... ٧. x ١ x ١ جيبايسموازيل ٥

سنتي سعيد عتيق

٥.٥.٢٠١٧

توقيع الطبيب :

/ / التاريخ:
الوقت:

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection.....
٩. x ١ x ١ تامويفين
٦. x ١ x ١ بوتير
٦. x ١ x ١ وان المنا
٧. x ١ x ١ جيبايسموازيل ٥

Amherst

٥.٥.٢٠١٧

Magnif Blood
٦ TVU
+ more

توقيع الطبيب :

/ / التاريخ:
الوقت:



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

توقيع الطبيب: (م. م. م.)

أوامر العلاج: ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

التاريخ:
الوقت:

توقيع الطبيب:

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

أوامر العلاج: ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

التاريخ:
الوقت:

توقيع الطبيب:

(New Mammography)



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:..... 21/11/2020

For PORTH 4000 Cytis A
& Bort
M. Elsayed

/ / التاريخ:
الوقت:

توقيع الطبيب :

الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:.....

/ / التاريخ:
الوقت:

توقيع الطبيب :

٠١٠٠٦٤١٧٦٩
Sipi

٠١١٤٢٦٥٩٣٨٤



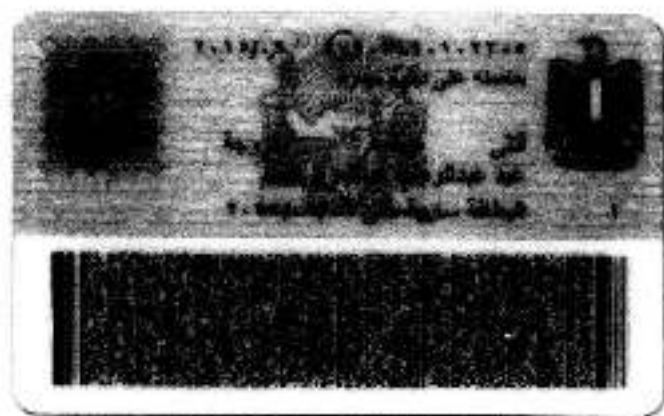
ERM036746430

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحصيل الشخصية

وفاء
محمد عبدالمطير احمد
اشرف مرغانيم . اللجنة
المطرية - القاهرة

٢٧٩.٧١١.٠١.٢٢.٥

GF0827925





To whom it may concern

Mrs Wafa Mohamed Abel moaty 40 years old female patient
presented with a diagnosis of right breast cancer after RT. WLE + Axillary
clearance

PATH: Infiltrating duct carcinoma G2, mass 3.5x2.2cm, LN -ve
0/17(T2N0) .

She was referred to us for PORT.

She received adjuvant post operative comprehensive radiotherapy.

Dose : 4500cGy/20f/4w 225 cGy/fx. + concomitant boost 1000cGy
/ 5 fx.

Started : 10-3-2020

Ended : 8-4-2020. With good tolerance .

Head of department
Dr. Hany William

8 - 4 - 2020



Name Wafaa Mohamed Abdelmoaty

Date: 7/8/2019

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

Known case of breast mass.

1. Chest:

- Right breast mass is seen measuring about 2.6 x 2.1 cm.
- No pathologically enlarged axillary lymph nodes.
- Few bilateral tiny 2-3 mm micro-nodules are seen (for follow up).
- No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall.
- Normal appearance of the dorsal vertebrae.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size with diffuse low CT attenuation denoting fatty infiltration. No focal lesions or biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenal glands.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Right ovarian cyst is seen measuring about 1.7 cm in diameter.
- UCD is seen.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic collections.

OPINION:

- ***Right breast mass.***
- ***Fatty hepatomegaly.***

Dr. Ahmed Rozeka, MSc

Dr. Amr Farouk, MD

Patient Name: Wafaa Mohamed Abdelmoaty.

Date: 24/12/2019

Tc-99m MDP bone scan

Technique :

Delayed Whole body bone scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP:

Report:

- Spondylo-degenerative changes are noticed in scoliotic dorsal & lumbar vertebrae.
- No hot spot that account for definite osseous deposits could be detected over the surveyed skeleton.
- Both kidneys are normally seen.

Opinion: -

- *No definite evidence of osseous deposits.*

Thanks for reference

Nuclear medicine Unit

Magdy kotb , M.D.



Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m6178

Female	: النوع	وفاء محمد عبدالمعطي	: اسم المريض
القاهرة	: العنوان	40 Y	: السن
24/10/2019 10:43	: تاريخ استلام العينة		: تاريخ اخذ العينة
18/11/2019 13.27	: تاريخ التقرير	مركز اورام دار السلام	: طالب التحليل
		مركز اورام دار السلام	: عناية

Primary Sample :

Paraffin Block

Tset :

ER & PR (according to Harvey scoring system)

Comment :

Technique:

Sample Recieved Was Treated by: - CONFIRM Anti-Estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal Primary antibody.- CONFIRM Anti-Progesterone Receptor (PR) (IE2) Rabbit Monoclonal Primary Ant.body.

Result:

ER: moderate nuclear staining of 80 % of tumour cells

PR: moderate nuclear staining of 10 % of tumour cells

Refrral Lab:

Comment:

Conclulsion:

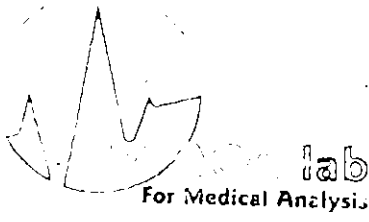
ER: POSITIVE (SCORE 7 / 8)

PR: POSITIVE (SCORE 4 / 8)

Pathologist:

د/أيناس رمزي

Lab Director: د/ تريزا ماهر



Lab code 507083 Req. Date 08/10/2022
Name وفاء محمد عبد المعطى مدام Sex Female Age 43 Years
Referred by حنان عزت د. Reporting Date 08/10/2022

Kidney Function Tests

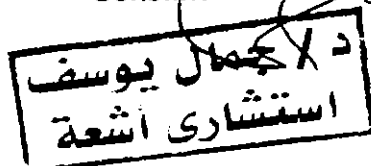
			<u>Reference Range</u>
Serum creatinine	0.85	mg/dl	0.5 - 1.5
Serum calcium (Total)	9.6	mg/dl	8.5 - 10.5
Serum calcium (Ionized)	1.2	mg/dl	1.10 - 1.31

- Normal Right side structure, tricuspid valve & junction (no mitral regurgitation, no pulmonary hypertension), with PASP= 23 mmHg.
- Normal left atrium.
- No regional wall motions abnormalities at rest.
- No masses or thrombi by TTE.
- Normal pericardium.
- Intact septum

Conclusion:

- Normal echo study.

DR/ GAMAL YOUSSEF
Consultant Radiologist





وزارة الصحة والسكان
أمانة المركز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
حرم، سابقاً

Radiology Request

طلب الشعاع

Patient name: مها محمد

Hospital NO: 01919982

Age: Sex: Date: 1/1

Time:

Diagnosis:

Exam required:

Mammography

Clinical data (Reason of study):

A case of breast cancer

Surgeries: for 1st follow up

Previous studies' result with dates:

US:

CT:

MRI:

Plain X-Ray:

القيمة		سعر الوحدة		الكمية المنصرفة	الكمية المطلوبة	الصف	مستل
جنيه	قرش	جنيه	قرش				
							1
							2
							3
							4
							5
							6
						الإجمالي	
الحسابات				قسم الأشعة		الطبيب المعالج	
الإسم:				الإسم:		الإسم:	
التوقيع:				التوقيع:		التوقيع:	

خطابات أورام

Patient Name : وفاء محمد عبدالمعطي

sex : female

Age: 40

Hosp.Word : CT

Patient status : outpatient

Path.No. : 846

IHC . No : 11863

Referring Doctor: السلام- هرمل

Date : 02-10-2019

Provisional Diagnosis: Request for Ki67 and E-cadherin.

Immunohistochemistry Report

CLINICAL/ RADIOLOGIC DATA

Lumpectomy with axillary clearance.

GROSS PATHOLOGY

Received 1 paraffin block.

IMMUNOHISTOCHEMISTRY

Immunostaining effectuated on 5 µm thick paraffin sections, the heat induced epitope retrieval using microwave, the ChemMate DAKO Envision, DAKO autostainer and the following antibodies:

- E- cadherin : positive on the neoplastic cells
- Ki67 : less then 20% of the neoplastic cells are positive.

CONCLUSION

Breast mass, lumpectomy, site unspecified : invasive duct carcinoma ONST, low proliferation fraction

Enclosed :

Slides :

Blocs :

مدير معمل الصبغات الهستومناعية

أ. د / هويدا عبدالعال

Director Immunohistochemical Lab

Prof. Howayda Abd El All

07-10-2019



Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m5519

Female	: النوع	وفاء محمد عبدالمعطي	: اسم المريض
القاهرة	: العنوان	40 Y	: السن
26/09/2019 13:08	: تاريخ استلام العينة		: تاريخ اخذ العينة
15/10/2019 09:14	: تاريخ التقرير	مركز اورام دار السلام	: طالب التحليل
		مركز اورام دار السلام	: عناية

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

HER2 neu (according to CAP scoring system)

Comment :

Technique :

Sample recieved was treated by : -VENTANA anti-HER2/neu (4E5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.

Result :

HER2/neu protein over expression : strong continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells.

Referral Lab :

Comment :

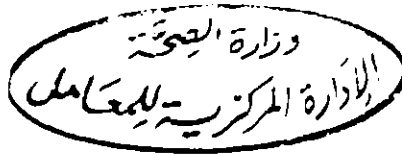
Conclusion :

HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : POSITIVE (SCORE 3+)

Pathologist:

د/اينس رمزي

Lab Director: د/ تريزا ماهر



A +ve فصيلة الدم



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
«هرمل سابقاً»

Doctor's Orders الأوامر الطبية

التشخيص:
اسم المريض: وفاء ك
نوع التغذية:
رقم الملف:

Chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canola site infection:

عجز وديس دم كليا نه
دهن مريض

هناك حالة
تغير كليا ١٠
توقيع الطبيب:

التاريخ:
الوقت:

Chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canola site infection:

تم حجز كيس دم من نفس الفصيلة
نرمس ألد
٩٩/٩/٩٠

AT
٩٩/٩/٩٠
(2847436)
٩/٩/٩٠

التاريخ:
الوقت:

توقيع الطبيب:



Patient name: وفاء محمد عبد العاطي

Date: 18/8/2021

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had right CBS, 1year ago.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Heterogenous dense fibro glandular density (ACR C)
- Bilateral scattered typically benign macro calcifications.
- Right breast LOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and mild diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound also showed right breast LOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with no evidence of recurrent mass lesions.
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex,
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Bilateral typically benign calcifications.
- (BIRADS 2)

Best regards,
Dr\ Nehal hamdey, FEBR, MSC.



Diagnosis:

Right breast mass, Lumpectomy with axillary clearance,

- **Mixed ductal and lobular carcinoma I**
- **In situ lobular and solid DCIS (5%).**
- **No lymphovascular emboli.**
- **No perinural invasion.**
- **Free margins**
- **LN 0/17**
- **Stage T2 N0.**
- **The case for IHC; (ER, PR, Her2, Ki67 and E-Cadherin)**

Prof. Dr. Lubna-Omar

Dr. Marwa Mahmoud

Prof. Dr. Essam Ayad



Pathology Report

Name: وفاء محمد عبد المعطى

Age: 40 years.

Clinical data: Right breast mass

Specimen type: Lumpectomy with axillary clearance

Date: 15/9/2019

Lab. Number: 846

Hospital Number: 2947/2019

Gross Description:

Two specimens were received:

- A piece of breast tissue; 6x5x4 cm, showing an ill-defined firm greyish white mass; 3.5x2.2 cm, located (1.2, 2, 1.5, 1.5, 1&1) cm from (medial, lateral, upper; lower, superficial & deep) margins respectively.
- Axillary specimen; 9x8 cm, entangling 17 nodules up to 2cm in diameter.

Microscopic Examination:

Microscopic examination revealed breast tissue showing infiltrating tumor formed of malignant ductal cells with moderate pleomorphism and moderate tubular differentiation. Other foci show infiltrating tumor formed of monotonous dyscohesive cells with hyperchromasia arranged in indian filing. No lymphovascular emboli. No perinural invasion.

DCIS 5%, solid variant. Foci showing in situ lobular carcinoma.

Surrounding breast shows fibrocystic changes.

Free margins, upper margin showed florid adenosis.

Lymph nodes 0/17 showing reactive sinus histiocytosis.



Investigations

Patient name:

MR. no:

As directed by prof. Dr. Hassan El-Zohry
→ Herceptin
→ Tamoxifen 20mg monthly

17/11/14
الشيخ
الشيخ
الشيخ

Checked & Reviewed by Dr.

Date: Time:



التاريخ المرضي PERSONAL HISTORY

Patient name: Mr.no:

Age: Sex: ☐ Male ☐ Female

Occupation:

Marital History: ☐ M ☐ S ☐ W ☐ D

Children: ☐ Yes ☐ No number

Special Habits: ☐ Smoking ☐ Coffee ☐ Alcohol

Allergy: ☐ Yes ☐ No Comment:

Adverse drug reaction: ☐ Yes ☐ No Comment:

Complaints:

Present History:

40 yrs old ♀ patient, postmenopausal 3 m ago after ch
underwent lumpectomy + AC 15/9/2014
PT - maxillary ductal & lobular carcinoma
- DCIS 5% I
- no lymphovascular emboli
- no perineural invasion
- free margin
- LN 0/17
- T2N0

Past History (hospital admission & surgery):

14/12/2015 - ER 7/8
Bone scan - PR 4/8
free - HER2 (+3)
- Ki67 20%
• surgical:
• Diabetes mellitus:
• Blood Transfusion:

Family History:

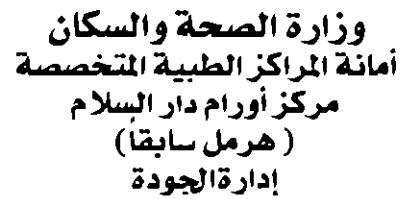
The patient received: 3x FEC => 3x Taxoter
adj ended on 10/2/2020
then patient was planned to start RTh

Psychosocial History: CAPCT 16/2/2020

Checked & Reviewed by Dr.

Date: Time:

low tiny bilateral
millimetric insignificant
Palm nodules
→ no other mets





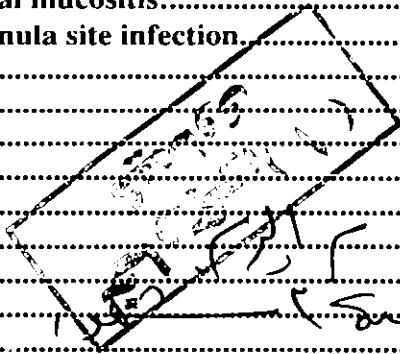
وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :
C. 19. / 09. 2019

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....



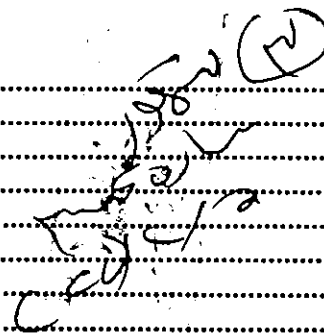
رئيس مركز أورام دار السلام
الوقت:

توقيع الطبيب :

د. خالد
م. خالد
د. خالد

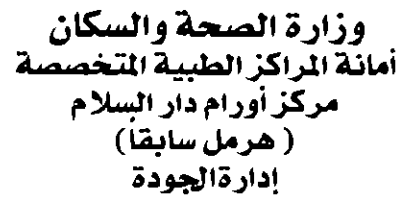
الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....



توقيع الطبيب :

التاريخ : / /
الوقت :



اسم المريض : د. فاطمة محمد
الرقم الطبي : ١٩ / ٤٧ / ع. ٢٩

الأوامر

Chest.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection.....

7-11-2019

K-C نزل دكس ١٠٠ ملغم
اراميد كين
كل يوم
بعد و امر
يا، امون
تروميتيك

قد عيى لمة ٢ / ٤
النايح:
الوصف:

تم صرف زوالاوت
80 غيلو
(20x1)

نوفع الطبيب :

(Handwritten signature)

best

اردین ہائی
۱۱/۷
۲۰۰۷ء



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

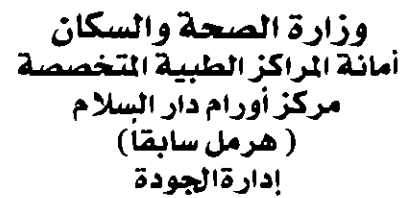
Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

chest:.....	الأوامر
Temp:.....	ON EX NAD.
Oral mucositis:.....	
Canula site infection:.....	
	1.8
	مولا ديس
	أراميس
	كاسيوم
	بودرام
	نيورفيت
	توقيع الطبيب : د. محمد قولا
التاريخ: 06/07/2018	
الوقت:	for BSA.

chest:.....	الأوامر	استغور هوني
Temp:.....		نينا حوس
Oral mucositis:.....		
Canula site infection:.....	8/5/2018	Bilat SM, free
	1.8	مولا ديس
	أراميس	
	كاسيوم	
	بودرام	
	نيورفيت	
	توقيع الطبيب : د. محمد قولا	
التاريخ: 06/07/2018		
الوقت:		

مرفق
Zoladex
+ مستور هوني
لجنة الكيمياء
06/07/18



اسم المريض : د. محمد بن عبد الله
الرقم الطبي : ٩٩٤٧ / ١٩

التاريخ:
الوقت:



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Dr. [Signature]

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

Zoladex 10, 8 mg

Arimidex 50

Oestradiol 0.5

clonidine

توقيع الطبيب :

التاريخ:
الوقت:

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

1/4/2023

→ Ca H

Prolia Postponed

→ for Arimidex / Zoladex

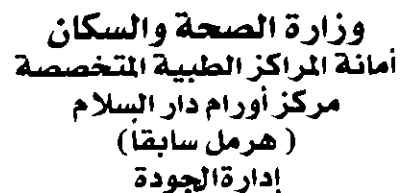
توقيع الطبيب :

التاريخ:
الوقت:

صيدلية خارجي

تم صرف ٢ حبة
٤/١
لم يصرح للقرار

تم صرف العلاج
٥/١
دايف



١٠٠



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

R/ Aramidex

R/ Zoladex 10.8 1x1 1x1x90 day

التاريخ: 26 / 11 / 2017
الوقت:

توقيع الطبيب :

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

20.11.2017

9.11.2017

9.11.2017

patient xfer to start chemo

for 2 weeks

التاريخ:
الوقت:

توقيع الطبيب :

9.11.2017
9.11.2017



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:..... 16/6/2021

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection.....

أراميدكس 1X1X60

زولادكس 3.6mg 120d

أوستيوا 1X1X60

أونيفالفا 1X1X60

16/6/2021

16/6/2021

16/6/2021

16/6/2021

التاريخ:

الوقت:

16/6/2021

16/6/2021

الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:.....

Mammogram & US in Sep 2021

Arimidex 1X1X60

Zoladex 3.6mg 120d

Osteo 1X1X60

Onelpha 1X1X60

14/7/2021

14/7/2021

التاريخ:

الوقت:

توقيع الطبيب :



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:.....

4. د حنان عزت

Temp:.....

Oral mucositis:..... vaginal bleeding

Canula site infection:.....

D & C - endometrial hyperplasia

7-X-1-X-1 أراميدكس

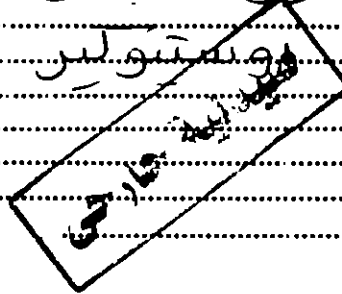
7-X-1-X-1 دولايدكس 2.7 كـ الجـ

7-X-1-X-1 دولايدكس 2.7 كـ الجـ

توقيع الطبيب :

0-1-19

/ / التاريخ:
الوقت:



الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:.....

- She is regular on hormonal tht;

- No CLO.

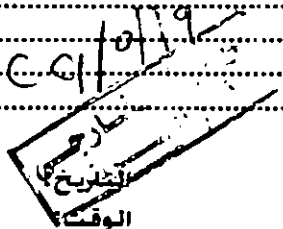
- Due for next mammography next Sept. 2021

2-X-1-X-1 أراميدكس

2-X-1-X-1 دولايدكس 2.7 كـ الجـ

2-X-1-X-1 دولايدكس 2.7 كـ الجـ

/ / التاريخ:
الوقت:



دار الأورام
0-1-19



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي : ER..PR..her.2...+ve

الأوامر

chest:..... ٩. x ١ x ١ ٥ تامويفين
Temp:..... ٦. x ١ x ١ بوتير
Oral mucositis:..... ٦. x ١ x ١ وان المنا
Canula site infection:..... ٧. x ١ x ١ جيسايسمواؤول ٥

سني سعيد علي

٥. ٥. + A / ٥٥

توقيع الطبيب :

/ / التاريخ:
الوقت:

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....
٩. x ١ x ١ تامويفين
٦. x ١ x ١ بوتير
٦. x ١ x ١ وان المنا
٧. x ١ x ١ جيسايسمواؤول ٥

Amherst

٥. ٥. + A / ٥٥

Magnif Blood
٦ TVU
+ maw

توقيع الطبيب :

/ / التاريخ:
الوقت:



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

توقيع الطبيب: (م. م. م.)

أوامر العلاج: ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

أوامر العناية: ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

أوامر التغذية: ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

أوامر العناية: ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

التاريخ:
الوقت:

توقيع الطبيب: (م. م. م.)

الأوامر

chest:.....
Temp:.....
Oral mucositis:.....
Canula site infection:.....

أوامر العلاج: ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

أوامر العناية: ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

أوامر التغذية: ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

أوامر العناية: ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

أوامر العناية: ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

توقيع الطبيب: (م. م. م.)

التاريخ:
الوقت:

توقيع الطبيب: (New Mamm - amul)



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:..... 21/11/2020

For PORTH 4000 Cytis A
& Bort
M. Elsayed

/ / التاريخ:
الوقت:

توقيع الطبيب :

الأوامر

chest:.....

Temp:.....

Oral mucositis:.....

Canula site infection:.....

/ / التاريخ:
الوقت:

توقيع الطبيب :